

Guide d'administration

Protocole *Dacarbazine*

Rédaction : mai 2012

Révision : novembre 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du mélanome métastatique¹⁻⁵.
ECOG 0-2.

Visée palliative.

Exclusions : métastases cérébrales, mélanome oculaire primaire².

- › Évaluation de l'INESSS : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (15 novembre 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

La dacarbazine s'administre à toutes les trois semaines jusqu'à progression ou toxicité inacceptable (ou pour un maximum de deux ans)^{2, 6}.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{3,4,7,8}

Médicament	Dose	Description
Dacarbazine	1 000 mg/m ² Jour 1*	› Dans 500 à 1 000 ml de NS ou D5% en 1 à 2 heures (protéger de la lumière) ^{3,9,10}
› Répéter aux 21 jours		

Considérations spéciales :

- › Ne pas utiliser si coloration rose de la solution (décomposition)¹⁰.
- › En périphérie, on peut utiliser une voie primaire de dextrose 5 % ou de NaCl 0,9 % à haut débit lors de l'administration de la dacarbazine, afin de réduire l'irritation veineuse¹⁰.
- › Afin d'éviter l'irritation au site d'injection, il est recommandé de reconstituer la solution avec du dextrose 5 % ou du NaCl 0,9 % ce qui permet une meilleure isotonicité. On suggère aussi de préparer la solution de façon extemporanée et de la protéger de la lumière afin de prévenir la photo dégradation qui pourrait être responsable de la toxicité locale⁷.

*Un schéma d'administration sur 5 jours a aussi été étudié mais il comporterait un risque plus élevé de toxicité hépatique et est moins pratique donc ne présente aucun avantage.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - o Aucune au préalable⁷.
- › **Antiemétiques :** potentiel émétique élevé (> 90 %)^{11,12}.
 - o Pré-chimiothérapie: aprépitant 125 mg PO + sétron + dexaméthasone 12 mg PO ou IV.
 - o Post-chimiothérapie: aprépitant 80 mg PO DIE pendant 2 jours + dexaméthasone 8 mg PO DIE pendant 3 jours. Au besoin : métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.
 - ♦♦♦Malgré le potentiel hautement émétisant de la dacarbazine, l'aprépitant n'a pas été étudié avec ce régime. Son utilisation demeure à la discrétion des cliniciens.♦♦♦
- › **Syndrome pseudo-grippal:**
 - o L'acétaminophène au besoin peut être utilisé dans les 48 heures suivant le traitement^{3,13}.
- › **Photosensibilité :**
 - o L'application d'un écran solaire avec un FPS de 30 ou plus est conseillée⁷.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale¹³⁻¹⁵

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Dacarbazine	Pas de recommandations en raison de l'absence de données pharmacocinétiques ou sur l'innocuité chez les patients atteints d'insuffisance rénale ¹⁴ Par contre certains cliniciens préconisent l'ajustement suivant ¹⁵ : Clcr > 60 ml/min : 100 % de la dose Clcr 46-60 ml/min : 80 % de la dose Clcr 31-45 ml/min : 75 % de la dose Clcr ≤ 30 ml/min : 70 % de la dose

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{13,15}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Dacarbazine	Activée et métabolisée au foie, mais on ne connaît pas dans quelle proportion l'insuffisance hépatique affecte la cinétique du médicament ⁷

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique³

Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
≥ 1,5	et	≥ 100	100% de la dose
< 1,5	et/ou	< 100	Retarder le traitement d'une semaine ad neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 100 x 10 ⁹ /L. Conserver la même dose au cycle suivant. Si retard de plus de 2 semaines : réduire la dose de 25%.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4 (sauf alopécie et hypersensibilité)

Grade	Ajustement posologique recommandé*
3 ou 4	› Retarder le traitement d'une semaine ¹⁶ . › Réduire la dose de 25 % si la toxicité est revenue à un grade 2 ¹⁶ . › Pas de modification de dose si la toxicité est revenue à un grade 1 ou moins ¹⁶ .

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** et la **thrombopénie** de grade 3 ou 4 sont peu fréquentes, mais peuvent nécessiter des ajustements posologiques ([voir section 3 - Guide d'ajustement posologique](#))^{2,3}.

Les **nausées et vomissements** sont fréquents et peuvent être sévères dans la phase aiguë et dans la phase retardée, nécessitant ainsi une prophylaxie pré et post-chimiothérapie ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))^{2,11,13}.

L'**anorexie** peut accompagner les nausées et vomissements et nécessiter un ajustement posologique ([voir section 3.4 - Guide d'ajustement posologique](#))^{2,3,11}.

De l'**hypotension** peut survenir durant l'administration de dacarbazine et semblerait associée aux doses plus élevées (> 850 mg/m²)^{8,13}.

De la **fièvre ou un syndrome grippal** peut être présent chez 10 % à 18 % des patients et nécessiter l'utilisation d'acétaminophène qui est indiquée pour diminuer les symptômes ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))^{3,13,15}.

La dacarbazine peut entraîner de la **photosensibilité** ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))^{2,7,13}. Des cas d'**hyperpigmentation** ont également été rapportés avec cette molécule¹³.

Une **toxicité hépatique sévère** (thrombose de la veine hépatique et nécrose subséquente ou Budd-Chiari) est survenue dans 0,01 % à 2,9 % des cas. Cet effet était présent surtout lors de l'administration sur 5 jours et au 2^e cycle. Un monitoring de la fonction hépatique est donc recommandé^{12,15-17}.

La dacarbazine est **irritante** (extravasation)¹². Une douleur au trajet de la veine peut également survenir d'où l'importance d'une dilution suffisante. Il serait également indiqué de prolonger le temps de perfusion (1 à 2 heures) afin de réduire la douleur au site d'injection¹⁰.

Tableau des effets indésirables³

Effets indésirables (n= 149)	Incidence globale (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Nausées	38	4	0
Vomissements	24	4	0
Douleur	39	13	0
Constipation	29	3	0
Anorexie	20	2	0
Fièvre	18	2	0
Fatigue	18	2	0
Asthénie	14	1	0
Céphalées	12	1	0
Somnolence	13	1	0
Thrombocytopénie	9	4	4
Anémie	11	0	1
Neutropénie	3	1	1

Version CTCAE non précisée dans l'étude

4.2. Interactions cliniquement significatives¹³

La **dacarbazine** est un substrat majeur du CYP450 1A2 et du CYP450 2E1.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 1A2 (p. ex. : ciprofloxacine, fluvoxamine, methoxalen, etc.)	↑ des concentrations de dacarbazine possible. <i>Sévérité : modérée.</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP450 1A2 (p. ex. : carbamazépine, rifampine)	↓ des concentrations de dacarbazine possible. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine
Avant chaque traitement (maximum 72 heures avant)	FSC, créatinine, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine

5. Références

1. National Comprehensive Cancer Network. Melanoma. V.1.2017 https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/melanoma.pdf, consulté en ligne le 22 novembre 2016.
2. Falkson CI, Ibrahim J, Kirkwood JM, Coates AS, Atkins MB, Blum RH. Phase III trial of dacarbazine versus dacarbazine with interferon alpha-2b versus dacarbazine with tamoxifen versus dacarbazine with interferon alpha-2b and tamoxifen in patients with metastatic malignant melanoma: an Eastern Cooperative Oncology Group study. J Clin Oncol 1998;16(5):1743-51.
3. Middleton MR, Grob JJ, Aaronson N, Fierlbeck G, Tilgen W, Seiter S, et coll. Randomized phase III study of temozolomide versus dacarbazine in the treatment of patients with advanced metastatic malignant melanoma J Clin Oncol 2000;18(1):158-66. Erratum in: J Clin Oncol 2000 Jun;18(11):2351..
4. Patel PM, Suci S, Mortier L, Kruit WH, Robert C, Schadendorf D, et coll. Extended schedule, escalated dose temozolomide versus dacarbazine in stage IV melanoma: final results of a randomised phase III study (EORTC 18032). Eur J Cancer 2011;47(10):1476-83.
5. Bedikian AY, DeConti RC, Conry R, et coll. Phase 3 study of decosahexaenoic acid-paclitaxel versus dacarbazine in patients with metastatic malignant melanoma. Ann Oncol 2011;22:787-793.
6. Mc Dermott DF, Sosman JA, Gonzalez R, et coll. Double-blind randomized phase II study of the combinaison of sorafenib and dacarbazine in patients with advanced melanoma: A report from the 11715 Study Group. J Clin Oncol 2008;26:2178-85.
7. Dorr RT, VonHoff DD. Cancer chemotherapy handbook. 2nd edition. Norwalk: Appleton & Lange, 1994.

8. Corporation de soins de la santé Hospira. Monographie de Dacarbazine. Kirkland, Québec. Novembre 2016.
9. Jelic S, Babovic N, Kovcin V, Milievic N, Milanovic N, Popov I, et coll. Comparison of the efficacy of two different dosage dacarbazine-based regimens and two regimens without dacarbazine in metastatic melanoma: a single-centre randomized four-arm study. *Melanoma Res* 2002;12(1):91-8.
10. Dacarbazine dans : Morris ME et coll. Manuel de pharmacothérapie parentérale. Hôpital d'Ottawa, 35^e Ed. 2014.
11. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
12. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
13. DRUGDEX[®] System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> Consulté en ligne le 22 novembre 2016.
14. Lichtman SM, Wildiers H, Launay-Vacher V, Steer C, Chatelut E, Aapro M. International Society of Geriatric Oncology (SIOG) recommendations for the adjustment of dosing in elderly cancer patients with renal insufficiency. *Eur J Cancer* 2007;43:14-34.
15. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 22 novembre 2016.
16. Bedikian AY, Millward M, Pehamberger H, et coll. Bcl-2 Antisense (oblimersen sodium) Plus Dacarbazine in Patients With Advanced Melanoma: The Oblimersen Melanoma Study Group. *J Clin Oncol* 2006;24:4738-45.
17. Nashan D, Müller ML, Grabbe S, et coll. Systemic therapy of disseminated malignant melanoma: an evidence-based overview of the state-of the art in daily routine. *J EADV* 2007;21:1305-1318.